

Insuffisance d'analgésie — césarienne sous APM

Méthodologie, synthèse & Thèmes 1-2 (bloc, délai décision-naissance)



Champ : prévention, reconnaissance et prise en charge de l'insuffisance et de l'échec d'analgésie au cours de la césarienne sous anesthésie périmédullaire (APM) — Club d'Anesthésie Réanimation Obstétricale (CARO), avec le CNGOF, la SFAR, la SFMP, le CNSF, la SoFraSimS, des experts médecine légale, IADE, IBODE, le CIANE, l'association Césarine et la SFPP. Fréquence rapportée de l'insuffisance d'analgésie : 0,5-17 % pour la rachianesthésie, 1,7-20 % pour l'extension d'analgésie péridurale. 5 thèmes : (1) évaluation du bloc avant incision, (2) délai décision-naissance, (3) reconnaître et gérer la douleur avant/après incision, (4) prévention et gestion de l'état de stress post-traumatique (ESPT), (5) aspects médico-légaux.

Méthodologie : ce document ne comporte **aucun système GRADE** et ne décrit **aucun processus de cotation/vote formel** — chaque préconisation est introduite par « Les experts suggèrent que... » ou « Les experts rappellent que... », sans tag de force individuelle imprimé. **24 préconisations** au total sur les 5 thèmes ; parmi elles, **10 ont été identifiées comme « clés »** par les experts (marquées ★ dans les tableaux ci-après) — sélection éditoriale, pas un niveau de preuve.

Disclosure : P1.7 et P1.8 sont imprimées avec un texte rigoureusement identique dans le corps du document source (« qu'une analgésie péridurale imparfaite... mêmes critères de bonne pratique sont requis ») — possible doublon d'impression de la source, reproduit tel quel plutôt que silencieusement fusionné ou supprimé. Par ailleurs, la fréquence de l'insuffisance d'analgésie est chiffrée deux fois différemment dans la source, sans réconciliation : 0,5-17 % (RA)/1,7-20 % (extension d'APD) dans le résumé/l'introduction, contre « 5 à 10 % des cas » dans l'encart « Informer » du schéma décisionnel (Annexe) — les deux chiffres sont reproduits ici tels quels.

Les 10 préconisations clés (synthèse officielle)

- L'insuffisance et l'échec d'analgésie sont définis comme toute anesthésie périmédullaire conduisant à un complément souhaité par la patiente.
- Le confort exprimé par la patiente est tout aussi important que l'évaluation du niveau d'anesthésie ; un inconfort majeur doit être pris en compte.
- Une analgésie péridurale imparfaite pendant le travail expose au risque d'échec de conversion pour la césarienne en cours de travail ; l'échec peut aussi survenir lors d'une césarienne programmée sous rachianesthésie (mêmes critères de bonne pratique).
- L'évaluation du niveau sensitif avant l'incision repose sur le toucher léger ou le froid : niveau sensitif supérieur bilatéral et symétrique en T6 au toucher ± T3 au froid requis (T6 = pointe xiphoïde, T4 = ligne mamelonnaire).
- En cas de suspicion d'acidose fœtale, l'obstétricien décide du degré d'urgence et communique de manière intelligible (ex. code couleur validé en équipe).
- Une anesthésie générale doit être réalisée en présence d'une insuffisance d'anesthésie constatée juste avant ou dès l'incision pour césarienne code rouge.
- Une pause opératoire doit être faite en cas de douleur peropératoire afin d'évaluer et traiter la douleur de manière adaptée au contexte.
- Une anesthésie générale doit être réalisée en cas d'échec de la gestion médicamenteuse de la douleur, même avant clampage du cordon.
- L'insuffisance d'analgésie doit être tracée, l'anesthésie renforcée, la naissance accompagnée, puis l'expérience douloureuse débriefée avec l'équipe, en particulier les soignants impliqués dans la prise en charge.
- Une évaluation des pratiques doit être réalisée (taux et indications des césariennes en extrême urgence, taux de conversion en AG suite à un échec d'APM).

Thème 1 — Évaluation du bloc avant incision

Réf.	Préconisation
P1.1 ★	L'insuffisance et l'échec d'analgésie sont définis comme toute anesthésie périmédullaire conduisant à un complément nécessaire par la patiente.
P1.2 ★	Le confort exprimé par la patiente est tout aussi important que l'évaluation du niveau d'anesthésie. L'existence d'un inconfort majeur doit être pris en compte.
P1.3 ★	L'évaluation de l'adéquation du niveau sensitif repose sur la sensation de toucher ± de froid. Un niveau sensitif supérieur bilatéral et symétrique en T6 au toucher ± en T3 au froid est requis (T6 = pointe xiphoïde, T4 = ligne mamelonnaire).

Insuffisance d'analgésie — césarienne sous APM

Méthodologie, synthèse & Thèmes 1-2 (bloc, délai décision-naissance)



Réf.	Préconisation
P1.4	Le test de pincement cutané par l'obstétricien doit être systématiquement réalisé, même en urgence, au niveau de la zone d'incision, toujours au plus haut, en limite du champ opératoire (ombilic).
P1.5	Pour la rachianesthésie (RA), une dose de bupivacaïne hyperbare (HB) supérieure à 10 mg limiterait le risque d'échec — dose à adapter aux tailles extrêmes et à la présence d'un syndrome de compression cave.
P1.6	La rachianesthésie-péridurale combinée (RPC) peut limiter le risque d'échec par la présence du cathéter péridural permettant l'injection d'un complément anesthésique.
P1.7 ★	Une analgésie péridurale imparfaite pendant le travail obstétrical expose au risque d'échec de conversion de la péridurale analgésique en péridurale anesthésique pour la césarienne en cours de travail.
P1.8	Une analgésie péridurale imparfaite pendant le travail obstétrical expose au risque d'échec de conversion de la péridurale analgésique en péridurale anesthésique pour la césarienne en cours de travail. <i>(texte identique à P1.7 dans la source — voir disclosure page 1.)</i>
P1.9 ★	L'échec peut également survenir lors d'une césarienne programmée avec une rachianesthésie et les mêmes critères de bonne pratique sont requis.

Précisions : dose de bupivacaïne HB à minorer/majorer de ± 1 mg si taille <155 cm ou >170 cm ; adjonction de sufentanil (2,5-5 μ g) pour optimiser la qualité de l'anesthésie et allonger la durée d'action, sans effet délétère néonatal rapporté. RPC : bupivacaïne HB 5-8 mg intrathécale + morphinique liposoluble et morphine, cathéter péridural ajusté secondairement à la lidocaïne 20 mg/mL adrénalinée ou ropivacaïne 5-7,5 mg/mL après dose test.

Tableau — Facteurs de risque d'échec des différentes techniques d'APM (reproduit verbatim)

Type d'APM	Facteurs de risque d'échec
Rachianesthésie	Ponction effectuée trop basse (L5S1) ; dose insuffisante et/ou perte d'une partie de la solution ; ponction « à cheval » (orifice de l'aiguille entre dure-mère et arachnoïde) ; antécédent de chirurgie du rachis.
Extension péridurale	Nombre de bolus administrés en péridurale pendant le travail ; scores de douleur élevés (EVA ≥ 4) dans les 2 h précédant la césarienne ; degré d'urgence de la césarienne ; parturiente de grande taille. <i>FDR controversés dans la littérature</i> : dilatation cervicale lors de la césarienne, IMC maternel, APD plutôt que RPC initiale, entretien par perfusion continue plutôt que PCEA/PIEB, durée du travail et dose totale de mélange analgésique reçue.

Thème 2 — Délai décision-naissance & communication

Réf.	Préconisation
P2.1 ★	En cas de suspicion d'acidose fœtale, l'obstétricien décide du degré d'urgence de la césarienne et communique de manière intelligible avec les autres acteurs, par exemple à l'aide d'un système de communication simplifié et validé en équipe (type code couleur).
P2.2	Dans chaque maternité, les procédures de transfert, d'installation des patientes et de modalité d'anesthésie en salle de césarienne doivent être optimisées pour minimiser le temps décision-incision.
P2.3	La possibilité de réaliser un enregistrement du rythme cardiaque fœtal (RCF) à l'arrivée en salle de césarienne est une préconisation forte du CNGOF et du CNEMM (Comité National d'Experts sur les Morts Maternelles).
P2.4 ★	Une évaluation des pratiques pourrait être réalisée avec comme indicateurs le taux et les indications des césariennes en extrême urgence, ainsi que le taux de conversion en anesthésie générale suite à un échec d'APM.

Précisions : le risque d'insuffisance d'analgésie lors de conversion des péridurales pour césarienne en urgence est rapporté 40 fois plus fréquent dans les césariennes code rouge — contrôler le RCF à l'arrivée au bloc peut faire reconsidérer le délai décision-incision. *(Disclosure : le résumé/la méthode de la source nomme ce thème « délai décision-extraction », le titre de section retenu ici — « délai décision-naissance » — est celui imprimé en tête de la section correspondante.)*

Insuffisance d'analgésie — césarienne sous APM

Thèmes 3-5 (douleur, ESPT, médico-légal), annexe décisionnelle & sources



Thème 3 — Reconnaître et gérer la douleur avant/après incision

Réf.	Préconisation
P3.1 ★	Réaliser une pause opératoire en cas de douleur peropératoire afin d'évaluer et traiter la douleur de manière adaptée au contexte.
P3.2 ★	Réaliser une anesthésie générale en cas d'échec constaté d'une APM juste avant ou dès l'incision pour césarienne code rouge.
P3.3	Administrer par voie intraveineuse de faibles doses d'un opioïde de courte durée d'action (alfentanil ou rémifentanil) ou des doses infra-anesthésiques de propofol ou kétamine en cas d'insuffisance d'analgésie constatée en cours d'intervention.
P3.4 ★	Réaliser une anesthésie générale en cas d'échec de la gestion médicamenteuse de la douleur, même avant le clampage du cordon.
P3.5	L'efficacité de toute action de complément d'anesthésie doit être réévaluée.

Précisions : le délai décision-extraction (15-30 min) restreint le choix technique lors d'une césarienne code rouge — l'AG s'impose en cas de douleur dès l'incision. Complément IV : privilégier les opiacés en 1^{re} intention (préserver la ventilation spontanée, associer une oxygénation) ; hypnotiques envisageables (propofol, kétamine) ; opioïdes/hypnotiques avant clampage du cordon peuvent dégrader transitoirement le score Apgar — à signaler au néonatalogue.

Thème 4 — Prévention et gestion de l'état de stress post-traumatique (ESPT)

Réf.	Préconisation
P4.1	Informar les femmes, en préparation à l'accouchement et dans les feuillets d'information, de l'éventualité d'une analgésie insuffisante et des solutions possibles, y compris en cas de césarienne.
P4.2 ★	Tracer l'insuffisance d'analgésie en cours de césarienne, renforcer l'anesthésie locorégionale et/ou générale, accompagner la naissance puis débriefing l'expérience douloureuse avec l'équipe, en particulier les soignants impliqués.
P4.3	Identifier la sidération et réaliser le soin psychique d'urgence (defusing) en postpartum ; à distance, diagnostiquer l'ESPT en explorant le bien-être maternel et la relation mère-enfant, puis confier la patiente à des spécialistes de l'ESPT pour une psychothérapie adaptée.

Précisions : l'état de sidération se manifeste par un mutisme ou un discours pauvre, un comportement maternel « opératoire »/automatique face au bébé, une absence d'émotions positives ou négatives — le témoignage du conjoint peut aider à le détecter. Le defusing (« déchocage psychologique ») vise à éviter un nouveau traumatisme et à soutenir activement les mécanismes de défense de la patiente.

Thème 5 — Aspects médico-légaux

Réf.	Préconisation
P5.1	Une information préanesthésique adaptée (art. D. 6124-91 et D. 6124-92 du Code de la Santé Publique) est le fondement d'un consentement libre et éclairé, mais doit aussi en situer les limites, imperfections ou échecs.
P5.2	L'article L 1110-5-3 du Code de la Santé Publique dispose que « toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance [...] celle-ci devant être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée et traitée ».
P5.3	En termes de préjudice corporel, les dommages les plus fréquemment observés incluent la prolongation et la majoration de l'intensité des gênes temporaires partielles, une chronicisation des douleurs et l'apparition de troubles neuropsychologiques pouvant témoigner d'un syndrome de stress post-traumatique.

Insuffisance d'analgésie — césarienne sous APM

Thèmes 3-5 (douleur, ESPT, médico-légal), annexe décisionnelle & sources



Annexe — Aide à la décision

Reproduit en tableau depuis un rendu visuel à 200dpi de la source page 25 — aucune couche texte fiable pour ce schéma dans le PDF source.

Étape	Contenu
1. Informer / Surveiller (en amont)	Inform : techniques anesthésiques en cas de césarienne urgente/programmée ; possibilité d'échec des techniques d'APM ; stratégies proposées en cas d'échec ; fréquence 5-10 % des cas. Surveiller : qualité et symétrie de l'APD en cours de travail ; dose suffisante réinjectée en cas de conversion APD (15-20 mL de lidocaïne 2 % adrénalinée) ; niveaux sensitifs symétriques en T6 au toucher/T3 au froid (mamelon) avant incision ; analgésie cutanée au test à la pince.
2. Insuffisance au test à la pince / à l'incision	Pause opératoire — évaluation MAR/obstétricien du délai d'extraction attendu, puis conduite selon le type de césarienne (programmée/urgence différable, urgence, urgence extrême — réaliser selon le contexte : critères d'intubation difficile, repères anatomiques difficiles, antécédent de chirurgie rachidienne).
3a. Programmée/urgence différable — échec complet à 30 min (aucun niveau)	Privilégier la PRC, sinon 2 ^e rachianesthésie (même dose) ou AG.
3b. Programmée/urgence différable — bloc partiel à 30 min	Privilégier la PRC avec bupivacaïne dose minorée (5 mg) puis anesthésique local en APD ; ou APD ; ou rachi (bupivacaïne HB dose minorée 7-8 mg) ; ou AG en induction séquence rapide.
3c. Urgence	Communication avec l'obstétricien. APD : poursuite de l'extension. AG : induction séquence rapide.
3d. Urgence extrême	AG d'emblée : informer la patiente, préoxygénation, induction séquence rapide.
4. Insuffisance d'analgésie pendant la césarienne	Pause opératoire — évaluation de l'intensité de la douleur selon le contexte et la sévérité.
5a. Complément intraveineux	Opioïdes : alfentanil 5-10 µg/kg, ou rémifentanil bolus 0,3 µg/kg en 1 min puis 0,1 µg/kg/min. Hypnotiques à dose infra-anesthésique : kétamine, propofol. Prévenir le pédiatre.
5b. Anesthésie générale	En induction séquence rapide (option parallèle au complément intraveineux selon le contexte).
6. Après coup	Savoir accepter l'échec d'ALR menant à l'AG ; tracer l'insuffisance d'analgésie ; débriefing avec l'équipe ; visite postopératoire ; identifier l'état de stress post-traumatique.

Abréviations de la source : APM = analgésie périmédullaire ; APD = analgésie périurale ; RA = rachianesthésie ; AG = anesthésie générale ; PRC = péri-rachi combinée (annexe) ; KT = cathéter ; VS = ventilation spontanée. Incohérence de la source : le corps du texte (P1.6) emploie l'acronyme RPC pour la même technique.

Sources et traçabilité

Déclaration d'intérêts : non précisée dans le document source (aucune section dédiée identifiée).

Document source : « Insuffisance d'analgésie au cours de la césarienne sous anesthésie périmédullaire : prévention - prise en charge immédiate et différée » — Préconisations du Club d'Anesthésie Réanimation Obstétricale (CARO), avec le CNGOF, la SFAR, la SFMP, le CNSF, la SoFraSimS, des experts médecine légale, IADE, IBODE, le CIANE, l'association Césarine et la SFPP. Comité de pilotage : D. Benhamou, H. Keita-Meyer (auteur correspondant), P. Deruelle, A. Evrard.

Version : 2021.

Méthodologie : aucun système GRADE, aucun processus de cotation/vote formel décrit — voir détail en page 1.

URL source : <https://sfar.org/download/preconisations-insuffisance-danalgesie-au-cours-de-la-cesarienne-sous-anesthesie-perimedullaire-prevention-prise-en-charge-immEDIATE-et-differee/?wpdmdl=32629>

Couverture : intégralité des 24 préconisations (5 thèmes), de la synthèse des 10 préconisations clés, du tableau des facteurs de risque d'échec des techniques d'APM et de l'annexe « Aide à la décision ». Bibliographie source : 34 références consolidées en une liste unique — non reproduite ici, l'argumentaire de chaque préconisation étant volontairement condensé à ses éléments actionnables (se référer au texte intégral pour le détail des études).

Avertissement — document de 2021 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des 24 préconisations et de l'annexe décisionnelle, mais ne remplace pas le texte intégral (rationnels complets, références bibliographiques) et n'est ni éditée ni validée par le CARO, le CNGOF, la SFAR ou leurs partenaires. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé.